

PRE-AMM

STATUT JURIDIQUE - REGULATION

Définition du produit de santé :

- Terme générique dont le but est d'englober différentes catégories de produits ayant trait à la santé humaine.
- Concept créé par la **loi du 1er juillet 1998**, relative au **renforcement de la veille sanitaire** et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme
- Liste établie à l'article L.5311-1 du CSP.

Catégorie de ces produits :

- Produits à finalité sanitaire sous le contrôle de **l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des produits de santé**.
- Objet d'une **réglementation** pour leur **mise sur le marché**, leur **délivrance** et la **gestion des incidents** résultant de leur utilisation.
- S'inscrit dans une **Stratégie nationale de sécurité sanitaire** → **Notion de vigilances sanitaires**.

Produits de santé =

1. **Médicaments**
 - **Tous** : matières lères , MDS, stupéfiants et psychotropes, vaccins, produits homéopathiques, à base de plantes, préparations magistrales et hospitalières, huiles essentielles, substituts nicotiniques, MTI, génériques...
2. **Produits Biologiques**
 - Organes, tissus, cellules utilisés à des fins thérapeutiques, produits de thérapie cellulaire et génique, produits sanguins labiles, produits thérapeutiques annexes, lait maternel collecté à usage thérapeutique...
3. **Dispositifs médicaux (in vivo) et DM de diagnostic in vitro (DMDIV)**
 - Thérapeutiques, de diagnostic in vivo, de diagnostic in vitro, produits contraceptifs et contragestifs, plateaux techniques, logiciels médicaux, produits de contactologie, les biomatériaux...
4. **Produits cosmétiques et de tatouage**
5. **Autres produits de santé**
 - Biocides (désinfectants, insecticides, produits antiparasitaires tels que les pédiculicides et les acaricides), produits diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS).

Statut juridique :

Un statut juridique comprend une **définition** (la définition du concept) et un **régime** (ensemble des règles applicables au produit défini).

Les définitions juridiques sont posées par une autorité normative :

- le **législateur** (la loi),
- le **pouvoir** réglementaire (le décret)

Le statut des produits de santé est posé dans la partie législative (L) ou réglementaire (R) du CSP.

Produits frontières :

- Le produit n'appartient à **aucune catégorie existante** de produits.
- Le produit est une **combinaison novatrice** : il est constitué d'au moins deux composantes différentes qui ont un statut réglementaire différent. On parlera alors de **produit combiné**.
- Terme principalement utilisé dans le domaine des dispositifs médicaux (DM)
- **Catégorie** de produits :
 - non connue du droit,
 - à la frontière du médicament,
 - doute sur leur statut.

DM / Médicaments :

Certains produits sont, par consensus, considérés comme médicament :

- Eau pour injections, liquides IV et solutés
- Agents de diagnostic in vivo

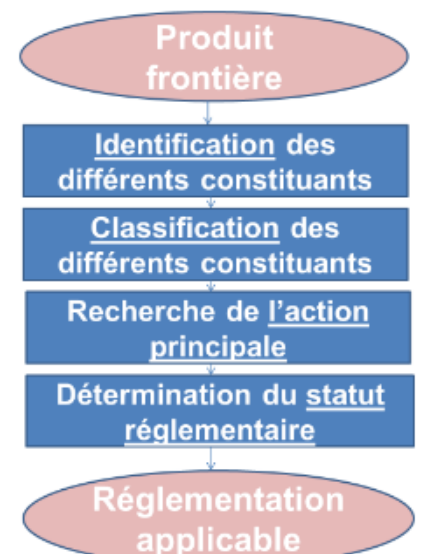
DM avec un médicament **accessoire** :

Pour être qualifié de DM le produit doit répondre à la définition de DM :

- Être destiné à des fins médicales
- Avoir une action principale obtenue par des **moyens autres que pharmacologiques ou immunologiques**

Méthodologie pour la définition du statut réglementaire d'un produit frontière

1. Identifier le produit et classer ses constituants
2. Rechercher le mode d'action principale pour connaître les prescriptions et les normes en vigueur qui s'y rattachent
3. Définir le statut réglementaire (appartenance du produit à l'entité permettant de connaître les exigences requises pour sa commercialisation) obtention de la mise sur le marché



La régulation / Réglementation :

Harmonisation **européenne** et **mondiale**

Relève de **guides de bonnes pratiques** nominatif écrits, **opposables** et **contrôlables** par l'ANSM.

Les Référentiels :

Code de **propriété intellectuelle** : protection des **créations intellectuelles** (brevets, marques...).

Code de la **sécurité sociale**.

Code de **l'environnement** : règles mises en place pour **protéger l'environnement et le consommateur** dans l'environnement et régissant les différents acteurs (consommateurs, entreprises, produits).

Les structures de régulation :

Structures de régulation sanitaire

- L'Agence européenne (EMA)

Création :

1995 : Agence européenne (EMEA)

2004 : European Medicines Agency (EMA)

- Structure commune à tous les EM
- Siège à Londres → Amsterdam en 2019

Champ de compétence et missions :

- Médicaments à usage humain
- Médicaments à usage vétérinaire
- Evaluation et surveillance (pharmacovigilance, essais cliniques)

- L'ANSM

Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au **renforcement de la sécurité sanitaire** du médicament et des produits de santé (AFSSAPS ANSM).

Élément clef du dispositif de sécurité sanitaire.

Gouvernance des produits de santé.

Pour garantir le **meilleur niveau possible de sécurité** d'emploi, de qualité et de bon usage des produits de santé.

Champs de compétence :

Agence d'évaluation et d'expertise

- Evaluation du bénéfice et du risque (B/R)
- Contrôle en laboratoire
- Elaboration et diffusion d'information

Pouvoir de police sanitaire

- Inspection sur le terrain des sites de fabrication, de distribution, d'essais
- Sanctions administratives et financières

Produits à finalité sanitaire

- Médicaments à usage humain
- DM
- DMDIV
- Produits sanguins

Produits à finalité cosmétique

- Produits cosmétiques
- Produits de tatouage

Organisation :

Commission **d'évaluation initiale du rapport bénéfices et risques** des produits de santé.

Commission de **suivi du rapport bénéfices et risques** des produits de santé

Commission de **prévention des risques** liés à l'utilisation de catégories de produits de santé.

Comités et groupes d'experts

ANSM et Médicaments :

Développement

- Autorisation des essais cliniques
- AMM

Fabrication

- Autorisation d'ouverture d'établissements
- Inspections

Commercialisation

- Visa de publicité
- Pharmacovigilance

ANSM et DM :



Structures de régulation socio-économique

- Haute Autorité de Santé (HAS)

Créée par la Loi du 13 août 2004 **relative à l'assurance maladie**.

Autorité publique **indépendante**, à caractère scientifique, dotée de la personnalité morale et disposant de **l'autonomie financière**.

Pour **promouvoir la qualité et l'évaluation** des soins et de la prévention.

Missions de la HAS :

Améliorer la qualité en santé

- Pouvoirs publics : éclairer leur décision
- Professionnels de santé : amélioration continue de leur pratique clinique

Évaluation scientifique de **l'utilité des médicaments des DM et des actes professionnels**.

Promotion des guides de bonne pratique et du Bon usage des soins/professionnels de santé et usagers.

Amélioration de la **qualité des soins dans les établissements**.

Les 8 commissions :

Parcours de soins et maladies chroniques (ALD)

Amélioration des pratiques professionnelles et de la sécurité des patients

Certification des établissements de santé

Commission de la transparence (médicaments)

Commission d'évaluation économique et de santé publique

Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNéDiMTS)

Qualité et diffusion de l'information médicale

Recommandations de bonne pratique

- **UNCAM**

- **CEPS**

CONCEPTION, BREVETS, MARQUES

Cycle de vie des produits de santé : les différentes étapes **Qualité, Efficacité, Sécurité** :

La clé : l'AMM/le Marquage CE

Conception  jusqu'à la destruction

**Sous l'angle gestion
des risques en Pré AMM**

Conception

Fabrication du prototype

**Sous l'angle gestion des
risques en Post AMM**

Commercialisation

Fabrication « industrielle »

Distribution, promotion

Utilisation, Surveillance

Elimination

Grandes étapes de la vie d'un produit de santé :

Développement PHARMACEUTIQUE ET BIOLOGIQUE

Synthèse, analyse du produit, mise en forme galénique

Développement PRÉ-CLINIQUE (études chez l'animal)

Etudes de toxicologie : toxicités

Etudes de pharmacodynamie : propriétés thérapeutiques
et mécanisme d'action

Etudes de pharmacocinétique : devenir du produit dans
l'organisme

Développement CLINIQUE (études chez homme)

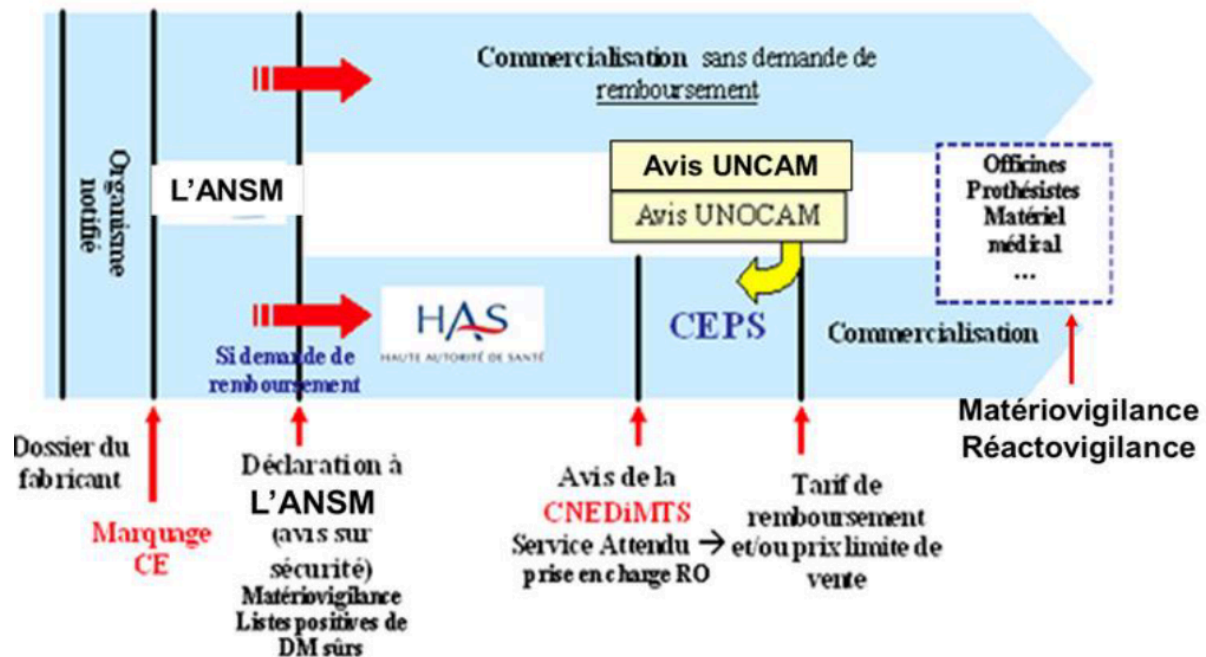
Phases I - II - III

Effet thérapeutique du produit- Etude du bénéfice/risque

DOSSIER D'AMM

**COMMERCIALISATION
SURVEILLANCE**

Le circuit du DM :



Phase préliminaire : Gestion du projet :

Qualification (statut) et fonction d'un produit :

- Cas du produit de santé : **intérêt thérapeutique** (Med) ou **performance** (DM), et **sécurité**.

Études de marché : un produit de santé doit **répondre à un besoin** de santé publique.

Situation du projet /stratégie de l'entreprise et /faisabilité.

Conception : les matières premières :

Choix des matières premières en fonction de la destination du produit de santé (PS).

Identification des Matières Premières (MP) = principes actifs, excipients, ingrédients, biomatériaux... des **expressions souvent différentes selon la nature du PS**.

Obligation d'**absence de toxicité** pour les MP et de « charges virales » (études de toxicité, de microbiologie, de biocompatibilité et d'analyse de risque)

Règlement européen REACH (depuis le 1er juin 2007) → prévention des risques chimiques en milieu professionnel/toxicité des MP (DM et cosmétiques) → établir **fiche de sécurité** (/risque toxicologique) pour chaque produit.

Rôle de la surveillance des **nanomatériaux**

Mode d'obtention des MP : synthèse, hémi-synthèse, extraction.

Possible existence de produits intermédiaires (→ contrôles).

Importance du lieu de fabrication : dans un EM de l'UE ou dans un Etat hors UE (d'où des contrôles appropriés pour garantir la sécurité).

Pour prévenir les risques de pénurie et de défaut de qualité des matières premières pharmaceutiques, mettant en jeu la sécurité des patients.

Définition matières premières :

Tous les composants des médicaments, c'est-à-dire :

- les substances actives
- les excipients (y compris l'eau!)

- les éléments de mise en forme pharmaceutique destinés à être utilisés chez l'homme ou chez l'animal ou à leur être administrés.

Les MP à usage pharmaceutique doivent être :

- **fabriquées, stockées**, selon les **Bonnes Pratiques de Fabrication** (BPF ou Good Manufacturing Practices, GMP)
- **distribuées** selon les **Bonnes Pratiques de Distribution** (BPD)

Pour garantir la qualité des MPUP jusqu'à leur livraison.

Code de la consommation Article L 411-1 :

Dès la 1ère mise sur le marché, les produits doivent **répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé** des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. **Le responsable** de la 1ère mise sur le marché d'un produit est donc **tenu de vérifier que celui-ci est conforme** aux prescriptions en vigueur.

Obligations de prévention : Les produits et services doivent, dans des **conditions normales d'utilisation**, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et **ne pas porter atteinte à la santé des personnes**.

Conception : La Formulation :

Choix de la formule en fonction de la **destination**.

Choix de la formule en fonction des **MP** (compatibilité).

Choix de la forme en fonction de la **destination**, de **l'identité** de l'utilisateur (enfants).

Protection de la découverte :

Les créations issues de la recherche et du développement sont protégeables par des **droits de propriété industrielle** qui est regroupée avec la propriété littéraire et artistique, dans la protection intellectuelle.

Elle a pour objet la **protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations**.

Le Brevet :

Titre délivré par les Etats qui permet, pendant une **période de 20 ANS**, d'interdire à tout tiers non autorisé d'utiliser son invention à des fins de fabrication ou de commercialisation.

Permet de **rentabiliser les efforts de Recherche et Développement** soit par l'exploitation directe, soit par la cession ou la concession de licences d'exploitation.

En contrepartie de ce droit exclusif, l'inventeur accepte de faire une **description loyale et complète de son invention**, mettant ainsi à disposition le fruit de ses recherches.

En France, les droits s'acquièrent auprès de l'**INPI** (Institut National de la Propriété Industrielle).

Un brevet peut aussi faire objet d'une **protection européenne** (OEB) ou **internationale** (OMPI).

Critère de base de la Brevetabilité :

La nouveauté : l'invention doit être nouvelle.

L'activité inventive : l'invention ne doit pas découler de manière évidente de l'état de la technique.

L'application industrielle : l'objet de l'invention doit **pouvoir être mis en œuvre** de façon concrète et pratique.

Types de brevets pour les médicaments :

Brevet de produit (T0) : porte sur la **molécule chimique** qui ne peut être brevetée que si la substance ou la composition est présentée pour la **première fois comme constituant** un médicament.

Brevet de synthèse (T 10-20 ans) : couvre le **procédé de fabrication**.

Brevet de formulation (T 15-30/40 ans) : porte sur la forme, la formulation **galénique**, les **associations** avec d'autres principes actifs...

Une **marque** pour un médicament :

Dénomination spéciale : nom de fantaisie

Peut faire l'objet d'une appropriation par son détenteur en tant que marque de fabrique ou de commerce.

Doit être disponible, ni trompeuse ni déceptive et sans risque de confusion

Donne une exclusivité d'exploitation.

Protégée pour une durée de 10 ans, indéfiniment renouvelable.

DÉVELOPPEMENT PRÉCLINIQUE

Etudes précliniques :

1- Qualité du produit de santé

Développement pharmaceutique (non clinique)

Maîtrise et validation **des procédés de fabrication**.

Études du **transfert industriel ou technologique** (TI ou TT) ou du passage du prototype à la spécialité pharmaceutique.

Études physico-chimiques sur PA, excipients, produits finis (caractères organoleptiques, pureté, identification, dosage...).

Preuve des caractéristiques essentielles de la substance active et du produit fini (exactitude de la dose).

Stabilité : fournir des données sur la façon dont la qualité d'un PA ou d'un produit fini, **varie en fonction du temps sous l'effet de facteurs environnementaux**, (T°, humidité, lumière) établir les conditions de conservation et la durée de validité des produits **date de péremption, date limite d'utilisation après ouverture (DLUO)**.

2- Intérêt thérapeutique/performance

Recherche de **l'intérêt thérapeutique** : études **pharmacologiques** et **pharmacocinétiques**.

- connaître la cible, les effets et le mécanisme d'action du produit et extrapoler à l'être humain
- connaître le devenir du médicament dans l'organisme

Recherche de la **performance** (DM) : études /tests mécaniques, tests physiques.

3- Sécurité

« Prérequis » non cliniques

Études in vitro et chez l'**animal**,

Recherche de **l'absence de toxicité** : essais toxicologiques, dont ceux relatifs à la mutagénèse, à la cancérogénèse et à la reproduction (MCR),

Validation de l'absence de « charges virales » : études microbiologiques,

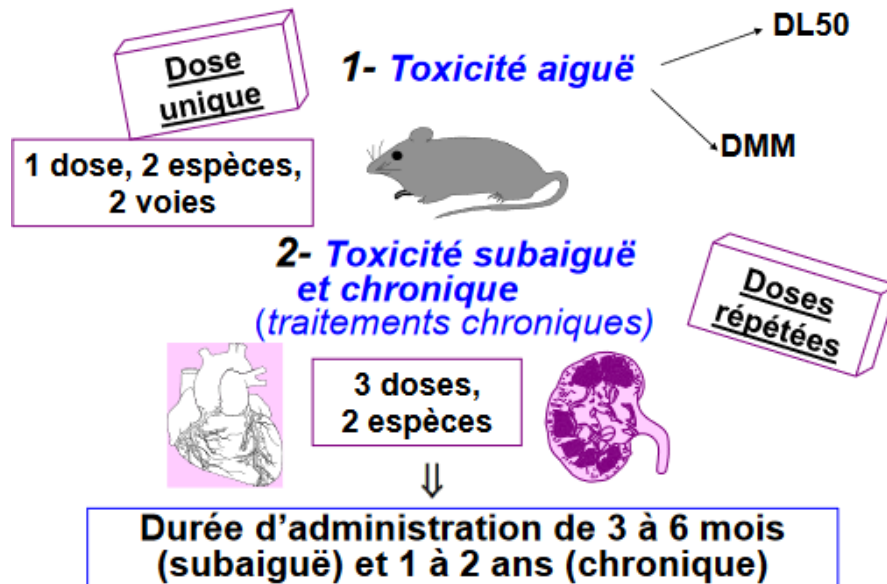
Cas des nanomatériaux.

Toxicologie :

Expérimentation chez l'animal.

Essais **très codifiés** (nombre, types d'animaux), qui visent à **éliminer les molécules trop toxiques** pour sécuriser les essais cliniques ultérieurs.

Méthodes alternatives (tests in vitro), possibles dans certains cas, mais aucune n'offre **pas le même degré de fiabilité** et d'acceptabilité.



A partir de ces données, un **dosage de base du médicament est déterminé** pour être administré à l'homme.

La dose initiale dépend des résultats en respectant un facteur de sécurité

Etude sur la fonction de reproduction :

Fertilité : on juge de l'effet du produit sur les capacités reproductrices des animaux



Études sur 1 espèce

Sur 1^{ère} génération « parents », puis on vérifie les effets du produit sur les générations F1 et F2

Sur des femelles en gestation

Effets du médicament sur le **développement des fœtus**

3 niveaux de doses



Études sur 2 espèces

Le cas du Thalidomide :

Immuno-modulateur utilisé de 1957 à 1962 comme sédatif et antiémétique.

12 000 cas de malformations : absence d'oreille interne, paralysie nerfs crâniens, phocomélie, amélie.

Inhibiteur de l'angiogénèse interférant avec le développement des vaisseaux sanguins surtout si prise au cours des 25/50 1ers jours de la grossesse.

A abouti à **l'obligation des essais de tératogénèse**, au renforcement de la pharmacovigilance (OMS) et à la restriction de prescription aux femmes enceintes.

Etudes de péri et post-natalité :

Sur des lots de femmes en **fin de gestation ou pendant la lactation**.

Impact du traitement sur la croissance du fœtus, la lactation et, le développement de la descendance.

Potentiel mutagène :

Évaluer la toxicité d'un produit sur le matériel génétique

Les lésions peuvent se situer au niveau :

- des **gènes** (mutations géniques)
- des **chromosomes** (mutations chromosomiques)
- du **génome** (variation du nombre de chromosomes)

Potentiel cancérogène :

Études requises lorsque le produit :

- est **susceptible d'être administré > 6 mois**
- appartient à une **série chimique potentiellement suspecte**
- a suggéré la possibilité d'un **pouvoir cancérogène** au cours d'études antérieures

Durée : 18 à 24 mois (2 espèces)

Ce n'est qu'à l'issue des essais précliniques, si les tests ont été satisfaisants, que la molécule pourra être administrée pour la première fois à l'homme

Dossier relatif à la qualité :

Ensemble de la **documentation relative au(x) principe(s) actif(s) et au produit fini** ⇒

Module 3 du CTD

- Données chimiques / Pharmaceutiques / Biologiques

Documentation **toxicologique et pharmacologique** ⇒ **Module 4 du CTD**

- Information Toxicologique / Pharmacodynamiques / Pharmacocinétiques

DÉVELOPPEMENT CLINIQUE

Pourquoi fait-on des études cliniques ?

Pour faire évoluer la prise en charge des patients.

Pour apporter de nouvelles connaissances et permettre le progrès médical.

Les études cliniques (Méd.) / L'évidence clinique (DM) :

Objectif : le produit destiné à être utilisé chez l'homme, doit **répondre à un besoin et être « sûr »**.

Donc il faut valider l'intérêt du produit, ses performances, sa sécurité... chez l'homme.

Pour valider **l'intérêt thérapeutique/la performance**, valider **l'absence de toxicité/la sécurité**. Cerner les effets indésirables et leur **maîtrise**. Valider la **posologie** /la méthode d'utilisation.

Encadrement réglementaire :

Loi n°2012-300 du 5 mars 2012 : Loi « Jardé » relative aux recherches impliquant la personne humaine (codifiée CSP).

Règlement (UE) 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain.

Règlement (UE) relatif aux essais cliniques de dispositifs médicaux : 2020.

BPC

2 phases d'évaluation avant autorisation :

- **Comité de protection des personnes (CPP)** (évaluation éthique, consentement)
- **ANSM** (évaluation scientifique, surveillance)

Accord de la CNIL (sécurité des informations et de leur traitement)

A partir d'octobre 2018, les essais cliniques de médicaments seront régis par les dispositions du règlement de l'UE.

Phase I :

Déterminer le profil de tolérance (clinique et biologique) → Dose maximale tolérée / Pharmacologie du produit

Volontaires **sains**, 20 à 50 sujets dans des centres spécialisés agréés

Doses de plus en plus fortes

Détermination de la DMT

Études couplées aux études de pharmacocinétique

Permet :

- **Mise au point** forme galénique.
- Informations /choix des doses et des modes d'administration.

Au terme de la phase I on a :

- une idée de la **dose maximale** à administrer
- on a optimisé la voie d'administration

Phase I peut aboutir à **l'arrêt du développement si toxicité** ou **absence d'effet thérapeutique**, sinon ⇒ Phase II.

Phase II :

Mettre en évidence les propriétés thérapeutiques

Déterminer la posologie

Malades sélectionnés et consentants 100 à 500 sujets

Tester une ou plusieurs doses

Études **contrôlées contre médicament de référence** (ou placebo)

Contrainte de **temps** : durée = 2 ans

Contrainte de **qualité**

Importance des **doses actives** qui seront choisies

Au terme de la phase II il est possible de préciser :

- l'activité du produit et son efficacité thérapeutique.
- la sécurité d'emploi à court terme.
- les doses appropriées.
- la relation dose/effet.

Phase III :

Phase pivot (go/ no go)

Confirmer l'efficacité et la sécurité sur une large population : balance Bénéfice/Risque

Malades sélectionnés et consentants 500 à 20000 sujets

Études contrôlées **contre produit de référence** (ou placebo)

Randomisation

Double aveugle

Sert à rédiger la notice.

Rapport efficacité/sécurité (bénéfice/risque) établi.

Posologie parfaitement déterminée (doses, voies et rythme d'administration).

Effets indésirables les plus courants bien cernés (gravité et fréquence).

AMM - MARQUAGE CE

Préparation des dossiers pour AMM :

Répondre à 3 critères ⇒ Qualité / Sécurité / Efficacité

Harmonisation Internationale :

Initiative prise par la **Commission Européenne et l'Industrie Pharmaceutique internationale**.

Objectifs :

- Profiter de l'expérience acquise au niveau européen pour atteindre un **accord international** sur les exigences d'enregistrement **ICH = International Conference on Harmonisation**.
- Définir les normes à appliquer pour la mise au point des nouveaux médicaments → **Guidelines sur la Qualité, la Sécurité, l'Efficacité**.

Autorités réglementaires d'Europe, du Japon, des USA + représentants de l'Industrie Pharmaceutique des 3 régions + observateurs de l'OMS, de l'AELE (Suisse), du Canada.

Les référentiels :

Directive 2001/83/CE modifiée

Règlement (CE) 726/2004 modifié CSP

Article L5121-8 CSP

- Toute spécialité pharmaceutique (..) doit faire l'objet, **avant** sa mise sur le marché ou sa distribution à titre gratuit, d'une **autorisation de mise sur le marché délivrée par l'ANSM**.

L'autorisation peut être assortie de conditions appropriées, notamment l'obligation de réaliser des études de sécurité ou d'efficacité post- autorisation.

Article L5121-9 CSP

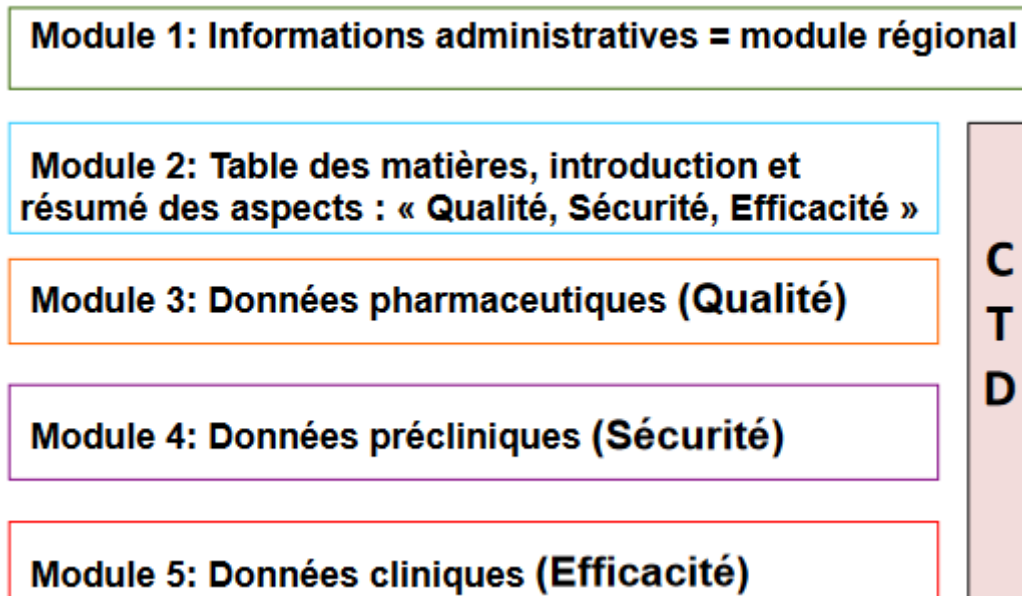
- L'autorisation est **refusée** lorsque l'évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament ou produit au regard des risques pour la santé du patient ou la santé publique liés à sa **qualité**, à sa **sécurité** ou à son **efficacité n'est pas considérée comme favorable (B/R < 0)**, ou que le produit n'a **pas la composition qualitative et quantitative déclarée**, ou que **l'effet thérapeutique annoncé fait défaut** ou est insuffisamment démontré par le demandeur, ou encore quand la **documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes** au dossier qui doit être présenté à l'appui de la demande (ex : informations administratives et les annexes : étiquetage, notice ...).

Commercialisation ⇔ Obtention de l'AMM :

Les acteurs économiques

- **Industriels** : Constitution du dossier d' AMM
- **Autorité compétente (ANSM/EMA) :**
 - Evaluation du dossier
 - Décision
 - Rapports publics d'évaluation européens (EPAR, publiés sur le site de l'EMA).

Le Dossier d'AMM :



CTD = Common Technical Document

Module 1 : Module administratif

Comprend les **spécificités régionales** (USA, UE, Japon) : formulaire de demande; **propositions de RCP, d'étiquetage et de notice**.

Le RCP (Summary of Product Characteristics) :

- présente sous forme harmonisée, l'ensemble des **informations utiles sur un médicament autorisé** dans un ou plusieurs Etats membres de l'UE.
- constitue une **carte d'identité officielle** pour le médicament.
- fait **partie intégrante de l'AMM**.
- évalué et approuvé au même titre que l'ensemble du dossier.

Module 2 : Les résumés

Comprend la **table des matières** (modules 2 à 5) et le résumé des modules « Qualité, Sécurité, Efficacité » (modules 3, 4 et 5).

Contient les **rapports des experts ⇔ évaluation critique** des éléments exposés par le demandeur / à la qualité technique, la sécurité d'emploi et l'efficacité thérapeutique.

Module 3 : Module Pharmaceutique

Présente toutes les **données relatives à la fabrication et au contrôle de la qualité** du produit (application des BPF).

Contrôle des MP, Description et justification de la formulation, Choix des procédés de fabrication et contrôles, Comprend la documentation chimique, pharmaceutique, biologique, biotechnologie et galénique du produit.

Module 4 (S) : Partie Préclinique :

Pharmacologie et toxicologie (application des BPL).

Module 5 (E) : Partie Clinique

Études cliniques et/ou bibliographie (génériques) (application des BPC)

AMM : Critère d'obtention :

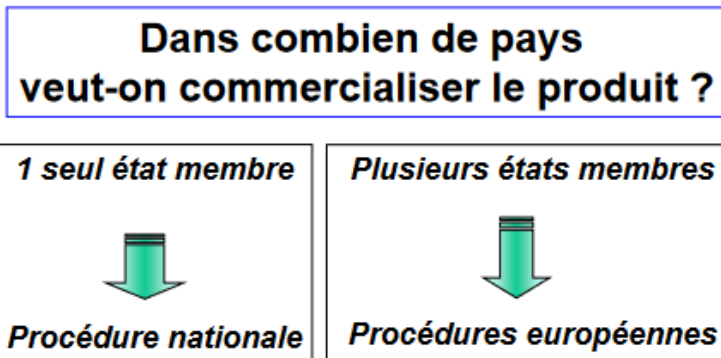
Accordée si le demandeur justifie qu'il a procédé à la **vérification de l'innocuité du produit** dans des conditions normales d'emploi, et de son **intérêt thérapeutique**, ainsi qu'à son **analyse qualitative et quantitative** et qu'il **dispose d'une méthode de fabrication et de procédures de contrôle**, de nature à garantir la qualité du produit.

AMM octroyée pour une **durée initiale de 5 ans**.

Elle précise : **posologie, indications, contre-indications et précautions d'emploi**, conditions de **conservation** du médicament ainsi que mentions de la **notice** et de l'étiquetage.

La décision s'accompagne du classement du produit dans les catégories suivantes :

- médicament non soumis à prescription obligatoire
- médicaments soumis à prescription obligatoire
- médicament soumis à prescription spéciale (psychotropes, stupéfiants)
- médicaments soumis à prescription restreinte (RH, PRS, PH, PIH, SP).



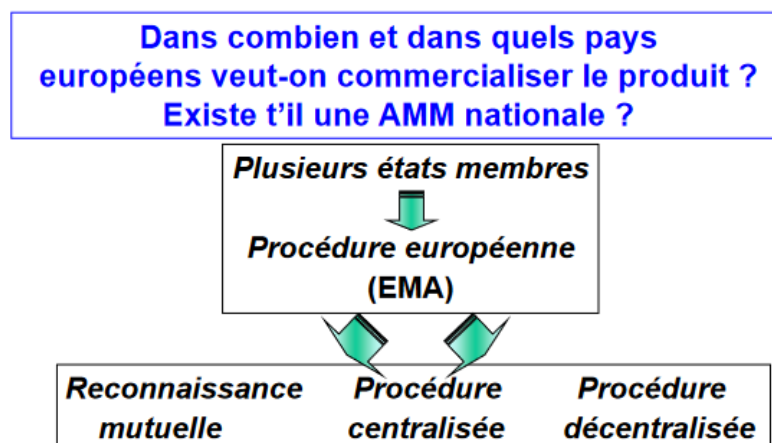
Procédure Nationale :

Produits concernés (essentiellement des PA connus) :

- **Extension de gamme** de produits dont l'AMM est nationale (nouveau dosage, nouvelle forme pharmaceutique, etc...)
- **Génériques** (90% des nouvelles demandes d'AMM nationales)
- **Nouvelles combinaisons** (associations fixes de produits actifs)

AMM dans un seul état membre

Procédures Européennes :



Procédure Centralisée :

Règlement (CE) 726/2004 ⇔ Procédure obligatoire pour :

- médicaments de **haute technologie ou issus de certains procédés de biotechnologie** (thérapie génique, cellulaire et ingénierie tissulaire),
- **nouvelles substances** dans domaines suivants : cancer, maladies neurodégénératives, SIDA, diabète, maladies auto-immunes et autres dysfonctionnements immunitaires,
- médicaments désignés comme **médicaments orphelins**. (maladies rares)

Optionnelle pour les cas suivants :

- nouvelle substance active
- innovation thérapeutique, scientifique ou technique significative

Dans tous les cas, le médicament ne doit **pas être déjà enregistré** dans un des pays de l'union.

1 seule demande (EMA) ⇒ **AMM unique**, même nom de marque, même notice, même RCP et étiquetage unique.

Procédure de reconnaissance mutuelle :

Procédure **obligatoire** depuis le 1er janvier 1998 pour **tout médicament ayant déjà une AMM**, et destiné à être mis sur le marché dans plus d'un EM.

Ceci afin de garantir une uniformité des décisions à travers le marché commun.

Dénomination du médicament identique ou différente, RCP/notice/étiquetage identique.

Procédure décentralisée :

S'applique depuis 2005 si le **médicament n'est pas dans le champ obligatoire de la procédure centralisée**, et lorsqu'il n'a reçu **aucune AMM dans l'UE** au moment de la demande (≠ avec la Reconnaissance mutuelle).

La procédure démarre en même temps dans tous les Etats membres choisis par la firme.

Procédure **+ rapide et moins contraignante que la reconnaissance mutuelle**, et alternative intéressante à la procédure centralisée.

Suivi post-commercialisation :

Après la délivrance de l'AMM, l'ANSM peut, exiger du titulaire de l'autorisation qu'il effectue, dans un délai qu'elle fixe :

1. Des **études de sécurité post-autorisation** s'il existe des craintes quant aux risques de sécurité présentés par un médicament autorisé ;
2. Des **études d'efficacité post-autorisation** lorsque la compréhension de la maladie fait apparaître que les évaluations d'efficacité antérieures pourraient devoir être revues de manière significative ;
3. Un **suiti spécifique du risque**, de ses **complications** et de sa prise en charge médico-sociale, au travers d'un registre de patients atteints, lorsque le médicament, bien que retiré, est susceptible de provoquer un effet indésirable grave ;

Les études sont faites au plus près des conditions réelles de soins (en comparaison avec les traitements de référence disponibles lorsqu'ils existent).

Préparation des dossiers pour **Marquage CE** :

L'harmonisation Internationale :

A l'initiative de la **Commission européenne et de l'industrie des DM**.

GHTF (Global Harmonisation Task Force), devenu **IMDRF (International Medical Device Regulators Forum)**.

Autorités Réglementaires d'Europe, du Japon, des USA, du Canada, du Brésil et de l'Australie.

Observateurs de l'OMS, de l'AELE (Suisse).

Représentants de l'Industrie des DM des 5 régions.

IMDRF :

Objectifs :

- Convergence de la réglementation des DM entre les membres → **Guidelines sur la Qualité, la Sécurité, l'Efficacité**.
- **Guides MEDDEV** (European Medical Device Vigilance System) publiés sur le site de la Commission.
- A consulter quand le choix du statut du produit revêt certaines difficultés (Medicinal Product /Medical device).

Les référentiels :

Règlement (UE) 2017/745 du parlement européen et du Conseil européen du 5 avril 2017 relatif aux DM, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009, et abrogeant les directives du conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE.

Textes applicables dans un délai de 3 ans.

CSP.

Article L5211-3 du CSP

- Les DM **ne peuvent être importés**, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, **s'ils n'ont reçu un certificat attestant leurs performances** ainsi que leur conformité à des exigences (CE) essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.
- La certification de conformité est établie **selon la classe** dont relève le dispositif, soit **par le fabricant lui-même**, soit **par des organismes**, désignés à cet effet par l'ANSM ou l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'UE, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Evaluation de la conformité :

Critères d'évaluation : /annexes de la directive 93/42/CEE et à partir de 2020, à celles du règlement.

Outils :

- **Gestion des risques** ⇒ réalisée par le fabricant et contrôlé par l'Organisme notifié
- **Évaluation clinique** ⇒ réalisée par le fabricant et contrôlé par l'Organisme notifié

Organisme notifié français : GMED-LNE (compétent pour tous les DM).

N° d'identification = 0459

Après le marquage CE :

Le marquage CE engage la **responsabilité du fabricant** et permet la libre circulation du dispositif médical sur le territoire de l'UE.

Il est **valable 5 ans et est renouvelable**.

Pendant cette période, des audits de suivi sont réalisés.

Un **suivi post-marketing** (plan de SCAC : surveillance clinique après commercialisation) est réalisé.